

ชื่อกิจกรรม “การใช้ยาสมเหตุผล: กรณีศึกษา”

ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรี วิทยาการ

ผู้ช่วยอาจารย์ปวีตรา จรรย์สกุลวงศ์ ผู้ลิขิต

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕ เรื่อง “การใช้ยาสมเหตุผล: กรณีศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรี ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๗

การออกแบบวิธีสอนให้ประสบความสำเร็จ มี 10 ลำดับกลยุทธ์ ดังนี้ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบทเรียนอย่างชัดเจน 2) แสดงให้ดูหรือปฏิบัติให้เห็น 3) การใช้คำถามที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 4) สรุปการเรียนรู้โดยใช้ภาพหรือแผนภูมิ เช่น mind map concept map เป็นต้น 5) ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ 6) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน 7) ควรมีการยืดหยุ่นเรื่องเวลาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 8) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีการทำงานร่วมกัน 9) สอนการนำไปใช้ไม่ใช่เพียงแต่เนื้อหา 10) การสอนที่นำไปสู่ระดับปัญญา (meta-cognition) คือผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเอง ประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีเนื้อหาหลัก 3 ส่วนที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ ขั้นตอนและกรอบความคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จำนวน 10 ข้อ สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 สมรรถนะ และประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 17 ประเด็น ซึ่งในการออกแบบกรณีศึกษาสามารถทำภายใต้กรอบแนวคิดสมรรถนะ และประเด็นเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้มีแนวทางการสอนและไม่หลุดจากกรอบเนื้อหา โดยรายละเอียดของขั้นตอนและกรอบแนวคิดจำนวน 10 ข้อ สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 สมรรถนะ รวมถึงประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 17 ประเด็น มีรายละเอียดตามข้อมูลต่อไปนี้

ขั้นตอนและกรอบความคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1. ข้อบ่งชี้ (indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น
2. ประสิทธิภาพ (efficacy) เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง
3. ความเสี่ยง (risk) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
4. ค่าใช้จ่าย (cost) ใช้ยาอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
5. องค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น (other consideration) รอบรู้ รอบคอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบและใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทางวิชาการ
6. ขนาดยา (dose) ถูกขนาด
7. วิธีให้ยา (method of administration) ถูกวิธี

8. ความถี่ในการให้ยา (frequency of dose) มีความถี่ในการให้ยาที่เหมาะสม
9. ระยะเวลาในการให้ยา(duration of treatment) มีระยะเวลาการรักษาที่พอเหมาะ
10. ความสะดวก (patient compliance) โดยคำนึงถึงความสะดวกและการยอมรับของผู้ป่วย

สมรรถนะการใช้อย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา (Assess the patient)
2. สามารถร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ตามความจำเป็น (Consider the options)
3. สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการใช้ยาโดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและเคารพในมุมมองของผู้ป่วย (Reach a shared decision)
4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง (Administer safely)
5. สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ (Provide information)
6. สามารถติดตามผลการรักษา และรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาได้ (Monitor and review)
7. สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม (Prescribe safely)
8. สามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์ (Prescribe professionally)
9. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ยา ได้อย่างต่อเนื่อง (Improve prescribing practice)
10. สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นแบบสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Prescribe as part of a team)

ประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้อย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 17 ประเด็น ดังนี้

1. National Drug Policy (NDP) and concepts of RDU
2. Basic pharmacology (Pharmacodynamics) and Clinical pharmacokinetics
3. Irrational/ inappropriate use of medicine
4. Monitoring and evaluation impact of drug therapy
5. Adherence to treatment
6. Benefit-risk and cost assessment and decision making in prescription
7. RDU in common illness
8. Taking an accurate and informative drug history
9. Administer drug safely
10. Medication errors

11. Prescribing for patients with special requirements
12. Provide patients and careers with appropriate information about their medicines
13. Awareness of rational approach to prescribing and therapeutics
14. Ethics of prescribing and drug promotion
15. Complementary and alternative medicine
16. Multi-professional care team to improve drug use
17. Continuous professional development in RDU

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้จัดทำขึ้นประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของข้อมูลหลักทั้ง 3 ส่วนตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน
2. การกำหนดบางข้อของข้อมูลหลักทั้ง 3 ส่วนที่จะนำมาใช้ในกรณีศึกษา เช่น ในกรณีศึกษาที่ 1 มีการกำหนดใช้สมรรถนะที่ 1 2 4 และ 5 และมีการกำหนดใช้เนื้อหาในข้อ 4 5 9 10 11 จากจำนวนทั้งหมด 17 ข้อ เป็นต้น
 3. ผลการเรียนรู้ที่กำหนด
 4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
 6. สื่อการสอนที่ใช้
 7. วิธีการประเมินผล
 8. รายละเอียดของผู้ป่วยที่เป็นกรณีตัวอย่าง
 9. ระบุแนวทางการอภิปราย ครอบคลุมข้อมูลหลักทั้งสามส่วนได้แก่ สมรรถนะพยาบาล ประเด็นเนื้อหาหลัก และกรอบแนวคิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยระบุข้อที่ใช้ในกรณีศึกษา และอาจมีการเขียนตัวอย่างประเด็นอภิปราย เช่น สรรพคุณยา ผลข้างเคียงของยา ประวัติและพฤติกรรมการใช้ยา การสื่อสารกับผู้ป่วยในการใช้ยาและการสังเกตอาการข้างเคียงของยา เป็นต้น
 10. รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับอาจารย์ผู้สอน โดยอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ยาที่ใช้ และผลข้างเคียงจากยาต่างๆที่ปรากฏในกรณีศึกษา
 11. Quiz โดยจะเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษารายใหม่สั้นๆ เพื่อประเมินว่านักศึกษาสามารถนำสิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษารายใหม่ที่ถูกกำหนดขึ้นได้หรือไม่
- ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้ยาสมเหตุผล: กรณีศึกษา” ด้านการศึกษา คือ เป็นการบูรณาการหลักการใช้อย่างสมเหตุผลไปสู่สถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพในระบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการใช้อย่างสมเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานหออผู้ป่วย

.....

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- | | | |
|-----|------------------|-----------------|
| ๑. | รศ.ดร.วิมลรัตน์ | ภู่วราวุฒิพานิช |
| ๒. | รศ.ดร.ดวงรัตน์ | วัฒนกิจไกรเลิศ |
| ๓. | รศ.ดร.อรวมน | ศรียุกตศุทธ |
| ๔. | ผศ.ดร.ศรัณยา | โฆสิตะมงคล |
| ๕. | ผศ.ดร.ศรินรัตน์ | ศรีประสงค์ |
| ๖. | ผศ.ดร.วารุณี | พลิกบัว |
| ๗. | อ.ดร.ชลธิรา | เรียงคำ |
| ๘. | ผชอ.ปวีตรา | จริยสกุลวงศ์ |
| ๙. | ผชอ.ประพัฒน์สินี | ประไพวงษ์ |
| ๑๐. | ผชอ.ณัฏยา | ประหา |

ผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้
 ในหัวข้อ “การใช้ยาสมเหตุผล: กรณีศึกษา”
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ไตรสุขศรี
 วัน พุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น
 ณ ห้องประชุม ๕๐๗ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ ราย ตอบแบบประเมิน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐

๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนา

หัวข้อในการประเมิน	จำนวนคำตอบ (ราย/ ร้อยละ)			
	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ตอบ
ผู้นำสามารถนำประเด็นเสวนาได้ชัดเจน	๙ (๑๐๐)	-	-	-
ผู้นำเสวนาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	๙ (๑๐๐)	-	-	-
รูปแบบ และวิธีการนำเสวนาทำให้มีการวิเคราะห์ปัญหาได้ทั่วถึง	๘ (๘๘.๘๙)	๑ (๑๑.๑๑)	-	-
มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้	๘ (๘๘.๘๙)	๑ (๑๑.๑๑)	-	-
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามได้	๘ (๘๘.๘๙)	๑ (๑๑.๑๑)	-	-
หัวข้อเสวนาน่าสนใจ	๙ (๑๐๐)	-	-	-

๒) โดยสรุป ท่านเห็นว่าการเสวนาครั้งนี้อยู่ในระดับใด

ดีมาก ๗ ราย (ร้อยละ ๗๗.๗๘)

ดี ๒ ราย (ร้อยละ ๒๒.๒๒)

ปานกลาง -

ควรปรับปรุง -

๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี